

Información Paciente

Nombre : Antonio Moraga Gonzalez
Edad : 53a 8m 27d
Dirección : Los Cipreses 4183

Rut : 12.274.536-8
Fecha Nacto: 25/04/1969
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2214115
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 3706 2065

N° Epicrisis
338526

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 28/11/2022 02:27
Fecha Egreso : 21/01/2023 02:01

Días Estadía: 54

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Transplante hepatico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EGRESO UCI

Nombre: Antonio Moraga González
RUT: 12.274.536-8
Edad: 53 años
FI HLF: 26.10.22
FI UCI HLF: 16.11.22
FI UCI CASR: 28.11.22

ANTECEDENTES:

Patológicos: DHC Child C por OH. EDA 31.10.21: Varices residuales. Cicatrices de ligaduras previas. EDA 04.02.21: HDA variceal activa con 7 ligaduras.
Fármacos: furosemida, espironolactona, propanolol, lactulosa.
Alergias: no refiere.
Cirugías: no refiere
Hábitos: OH: abandonado
Hospitalizaciones: HDA variceal: ligadura de 7 várices esofágicas 04/02/22
Social: Tutora: Úrsula Riveros, esposa, TELÉFONO: 937062065. CESFAM: Villa OHiggins

HISTORIA DE INGRESO.

Paciente con antecedente de DHC secundario a OH (suspendido hace 1 año, Child C, con antecedente de PBE y HDA variceal) conocido por gastroenterología en policlínico. Ingres a el 26/10 por cuadro clínico caracterizado por dolor abdominal difuso, aumento de perímetro abdominal, CEG y nauseas, sin emesis, sin fiebre sin ictericia, al ingreso estudios revelan pleuroascitis, sin PBE, con imagen sugerente de atelectasia/NAC y enterocolitis no complicada.
Realizan inicialmente con paracentesis evacuador y diagnostica, antibióticos empíricos (inicialmente mpicilina/Sulbactam que luego se ajusta a Ceftriaxona/Metronidazol), inician terapia depletiva. En imágenes al ingreso se describe imagen sospechosa de hepatocarcinoma en de 11 mm + trombo mural de Art mesentérica superior con estenosis moderada, por lo que se indica

Fecha Epicrisis : 21/01/2023 02:08

Fecha Última Actualización: 21-01-2023 2:08:18

Página 2 de 5

anticoagulación.

Posterior a primera paracentesis evoluciona con deterioro progresivo de función renal, que en un inicio responde a volemización con albúmina, posteriormente presenta aumento progresivo de edema periféricos, dolor torácico tipo pleurítico, en relación a pleuroscitis, se realiza nueva paracentesis evacuadora de 3 litros y se ajusta terapia diurética, en relación a esto último evoluciona con mayor deterioro de función renal con Crea reportada hasta 3.4 sin embargo diuresis conservada. Evaluado por gastroenterología quien considera que no califica como, síndrome hepatorenal, dado deterioro de función renal en contexto de múltiples noxas (medio contraste, fármacos nefrotóxicos, paracentesis evacuadoras), se indica manejo con albúmina y terlipresina con aparente buena respuesta inicial, sin embargo, paciente evoluciona con síntomas respiratorios desde la madrugada del 16/11, presentado saturaciones límites, aumento del trabajo ventilatorio y requerimiento progresivo de O₂. Paciente con contacto Covid positivo, Test de Antígeno SARS-Cov 2: negativo, Rx de tórax con aumento de patrón intersticial bilateral a predominio derecho y aumento de derrame pleural, presenta deterioro rápido de mecánica ventilatoria, sin tolerancia a VMNI, es comentado al UCI por alto riesgo de falla, y previo a su traslado, es intubado bajo SRI, dado evolución tórpida. Ingresa con Fio₂ 100%, con NAD a dosis baja 0.05mcg/kg/hr, sedación fentanilo/midazolam. Se realiza POC con Ph 7.11 PO₂ 112 PCO₂ 33 Hco₃ 11.2 ELP: 130/4.3/103.

Laboratorios 16-11-22:

BT 2,79 - INR 1 - PH 7,38 - BIC 20 - CREA 4,26 (3,39) - PCR 5,9 - BUN 53 - AU 6 - ELP 138/4/105 - PT 5,3 - ALB 3,3 - HTO 29 - GB 6700 - PLAQ 84000

Microbiología:

16/11 HC I-II (pendientes) UC (Negativo) CAET (Negativo)

Panel molecular respiratorio: (P)

16/11 Ag Urinarios Legionella/Pneumococo (neg).

16/11 Test AG SarS Cov 2: NEG.

14/11 Cultivo Liq ascítico: Leucos 375 MNC 87% PMN 13% Proteínas < 2.0. Cultivo: PROCESO.

10/11 Liq ascítico: Proteínas totales < 2.0 Albumina < 1.0 MNC 99%. Cultivo NEG.

28/10 HVC AgsHB (NEG)

26/10 UC (neg) Cultivo Liq ascítico: Leucos 160 MNC 96% PMN 4% Proteínas < 2.0. Cultivo: neg.

Marcadores tumorales:

29/10 ACE: 0.8 (-), PSAT 0.07 (-) CEA <0.2) neg.

Imágenes:

TAC de Tórax, sin MC 08-11-2022.

Hallazgos: Tráquea y bronquios principales permeables.

Moderado - severo derrame pleural izquierdo, algo mayor que en estudio previo, que determina atelectasia completa del lóbulo inferior izquierdo y parcial del segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo.

No se observan focos de condensación de aspecto neumónico. Atelectasia subsegmentaria en el lóbulo inferior derecho.

Corazón de tamaño normal. No se observa derrame pericárdico.

Grandes vasos mediastínicos de calibre conservado. Adenopatía subcarinal con centro hipodenso de 10 mm. No se observan adenopatías hiliares ni axilares. En las imágenes complementarias del abdomen se identifican cambios morfológicos de daño hepático crónico, esplenomegalia y ascitis severa.

Impresión:

Moderado - severo derrame pleural izquierdo, con atelectasia completa del lóbulo inferior izquierdo y parcial del lóbulo superior izquierdo.

Adenopatía subcarinal inespecífica. Daño hepático crónico, esplenomegalia y ascitis severa.

TAC de cerebro sin MC 18-11-2022.

Sin Hallazgos de carácter Patológico.

TAC de Tórax sin MC 18-11-2022.

Estabilidad en cuantía del derrame pleural bilateral, moderado a izquierda y leve a derecha. Regresión del extenso patrón en empedrado en ambos pulmones, persistiendo focos de neumopatía multilobares en ambos pulmones parcialmente confluentes.

AngioTAC de Abdomen y Pelvis 18-11-2022.

Hallazgos de hepatopatía crónica avanzada con signos hipertensivos conocidos. Sin signos de Trombosis del eje porto-

Fecha Epicrisis : 21/01/2023 02:08

Página 2 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:21

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

esplenomesentérico.

Esplenomegalia por hipertensión portal. Además, hallazgos tomográficos de proctopancolitis, de probable origen inflamatorio infeccioso.

Ecocardiograma TT con Test de Burbuja 21-11-2022 (Dr. Gatica ¿ Ecocardiografista)

Cavidades de tamaño normal, con FE de VI conservada, Sin valvulopatía mitral ni Tricuspídea, con Test de Burbuja intensamente positivo de manera tardía, compatible con un Síndrome Hepatopumonar.

TAC de Tórax ¿ Abdomen ¿ Pelvis 25-11-2022.

Aumento del derrame pleural en hemitórax izquierdo y de atelectasia subtotal del volumen pulmonar ipsilateral. Ha disminuido neumopatía multifocal y derrame pleural en el volumen pulmonar derecho persistiendo opacidad y relleno alveolar en el LID. Se mantiene signos de daño hepático crónico e hipertensión portal, determinado por esplenomegalia e importante ascitis supra e infra meso cólica.

Leve disminución de los cambios inflamatorio infecciosos en marco colónico y asas de delgado.

EVOLUCIÓN EN UPC HLF.

- HDN: En lo hemodinámico, durante el ingreso paciente hipotenso, hipoperfundido, con requerimientos intermedios de DVA, en contexto de severa acidosis metabólica. Con un IC estimado por VTI de 3.0 L/min/m², se decide mantención de norepinefrina, se agrega epinefrina, corrección parcial de acidosis, y terapia inmunomoduladora. Se deja dosis de HFAV por 6 hrs, con adecuada respuesta desde un punto de vista perfusional, con clearance parcial de Ácido Láctico, dCO₂ que se estrecha de 9 a 3, SatVCO₂ de 70%. Posterior a ello, continúa con HDFVVC por 6 hrs más, bien tolerado, sin anticoagulación en contexto de plaquetopenia y coagulopatía. Posteriormente, durante el fin de semana, el paciente ha logrado barrer Ácido Láctico, actualmente en 14 mg/dL, con un Delta CO₂ de 3, SatVCO₂ de 74%. Sin requerimientos actuales de DVA.

EVOLUCIÓN UCI

- Hemodinamia: Hemodinamia: Inestable con sangrado activo de mucosa oral, mal perfundida, bajo soporte de DVA a dosis en aumento llegando hasta 0.03 mcg/kg/min, con caída de HB hasta 6.3 por lo que se hemotrasfundió y se renimó con evs, con adecuada repuesta disminuyendo notablemente. Se realizó control de hemostasia por parte de Maxiloacial. Por el momento parámetros de flujodependencia +, por lo que se renimara avidamente.

- Resp: Sedado en SAS 1 y con VM protectora en VC a través de TQT qx (realizada hace 8 d). Mientras no haya mejoría de complicaciones infecciosas. Por ahora no está en condiciones de destete

- Infecto: Ha tenido varias interurrencias, actualmente cubierto con linezolid (6to d) por ERV (último cultivo +) en cult liq peritoneal (11 enero) + profilaxis con Aciclovir, Cotrimoxazol forte y fluconazo l. Completó ATB por Enterobacter cloacae complex MR en CST (24-12-22) que también salió en pta Cultivo pta CVC (25-12-2022)
Se revisan exámenes y se detecta aumento en las copias de CMV de <1000 (3 enero) a 2600 (16 enero). Se discute caso con infecto y se decide iniciar valganciclovir por SNG

- Hepato-qx: 49 días post tx hepático + re exploración a los 3 días de tx por hemoperitoneo. Además, la semana pasada se realizó ERCP con instalación de prótesis en VB por ictericia persistente (hpy BT 18) + LPR (se evidencia salida de cte a cavidad abd, por lo que se explora, encontrando abundante ascitis +coleccion retrogastrica, se toman cultivos). Inmuposup con metilprednisolona + tacrolimus. SE ha mantenido con transaminasas elevadas. (GOT 105/GPT94). Últimas imágenes de hace 48 hrs muestran colecciones intraabd. Se discute CHB, quienes plantean controlar en 1 semana para definir eventual drenaje

- Nefro: TRR, hoy se había planteado HDF pero ante inestabilidad clínica se suspende, hoy con creat: 0.53, bun: 74.7, ELP: Na: 138, k: 4.4, cl: 101, vigilancia estricta.

- Coagulación: Con trombocitopenia persistente, que no sería de causa medular 1ra según hematología. Hoy control de 48.000, dentro del contexto de manejo con linezolid, pero mantengo ante gravedad y aumento leve, hoy sangrado evidente con hb: 6.3, se suspende profilaxis TVP. Se indica transfundir 2 U gre y 6 unidades de plaquetas.

- Nutrición: En seguimiento pro ANI por req de NPTC. NE a bajo flujo y regular tolerada
- Pcte con portación + Enterobacter cloacae productor NDM. Ante esto se trasladará a cohorte (discutido con jefatura unidad)

Paciente en muy malas condiciones generales, shock refractario con acidemia metabólica severa, a pesar de hemo-transfusiones persiste con HB: <6.5, además de hiperlactatemia severa > 124, presenta hipotensión sostenida y bradicardia progresiva hasta la asistolia, se comprueba ausencia de pulsos y se declara fallecida. Hora de muerte 02:00 horas.

Diagnóstico de Egreso

Shock hipovolemico - 1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

1. Trasplante Hepático. (Cx: 02-12-22)

2- DHC sobre agudo.

3. Sepsis de foco pulmonar

4. Hemotórax.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Hora de muerte: 02:00 horas

Plan Post Alta

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 21/01/2023 02:08



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 21-01-2023 2:08:18

Página 5 de 5

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

John Gutierrez González

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 21/01/2023 02:08

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:21

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar